

TEMA 7.10 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos del Ánimo: Intento Suicida y Suicidio

PERFIL EUNACOM 1.09.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El suicidio y el intento de suicidio representan una de las urgencias psiquiátricas más críticas en la práctica clínica. Aunque están íntimamente ligados a los **trastornos del ánimo**, su presencia es transversal a múltiples patologías mentales y situaciones de crisis. En Chile, el suicidio es un problema de salud pública mayor, con características epidemiológicas específicas que todo médico debe conocer para el examen EUNACOM.

Epidemiología del Suicidio en Chile

La forma en que los pacientes abordan el acto suicida varía según la intención y la letalidad del método:

- **Intento de Suicidio (Parasuicidio):** La inmensa mayoría de los intentos en Chile se realizan mediante **ingesta masiva de medicamentos**. Generalmente, estos casos no terminan en muerte debido a que el margen de tiempo terapéutico permite la intervención médica y a que el personal de salud cuenta con la preparación para el manejo de intoxicaciones.
- **Suicidio Consumado:** El método más frecuente en Chile para el suicidio logrado es el **ahorcamiento**.
 - Es especialmente prevalente en poblaciones privadas de libertad (cárceles).
 - En la Región Metropolitana (Santiago), destaca epidemiológicamente el suicidio en el **metro** (lanzarse a las vías).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda: - El método más **frecuente de intento** es la intoxicación medicamentosa. - El método más **frecuente de suicidio consumado** es el ahorcamiento.

Causas y Factores Etiológicos

El suicidio es multifactorial, pero la patología psiquiátrica es el denominador común en la mayoría de los casos:

- **Depresión:** Es la causa número uno de suicidio. Tanto la depresión unipolar como la fase depresiva del trastorno bipolar presentan un riesgo altísimo.
- **Trastorno Bipolar:** Especialmente en episodios mixtos o depresiones graves.
- **Trastornos Psicóticos:** Una **Esquizofrenia** descompensada o mal tratada puede llevar al paciente al suicidio, muchas veces mediado por alucinaciones imperativas (voces que ordenan el acto).
- **Trastornos de la Personalidad:** Principalmente los del **Cluster B** (dramáticos, impulsivos y erráticos).

El Suicidio en los Trastornos de Personalidad (Cluster B)

No todos los trastornos de personalidad tienen el mismo perfil de riesgo. El Cluster B es el más relevante:

TABLA 7.10.1: TRASTORNO DE PERSONALIDAD VS PERFIL DE RIESGO SUICIDA

TRASTORNO DE PERSONALIDAD	PERFIL DE RIESGO SUICIDA
Límite (Borderline)	Muy alto riesgo. Marcada impulsividad, autoagresiones y descontrol vital.
Antisocial	Riesgo asociado al aislamiento, consumo de sustancias o situaciones de encarcelamiento.
Histriónico	Suele realizar intentos para llamar la atención (gestos suicidas), pero pueden consumarse por error o descompensación grave.
Narcisista	Menor frecuencia de suicidio. Generalmente solo ocurre ante "heridas narcisistas" masivas o depresiones profundas.

NOTA CLÍNICA

Los pacientes con **Trastorno Límite de la Personalidad** a menudo utilizan la conducta suicida como un mecanismo de regulación emocional ante el abandono o la angustia extrema, lo que requiere un manejo especializado a largo plazo.

Manejo del Intento Suicida

Ante un paciente que llega a la urgencia tras un intento suicida, la conducta debe ser sistemática:

- **Estabilización Médica:** Priorizar el soporte vital según el método utilizado (manejo de vía aérea en ahorcamiento, lavado gástrico o antidotos en **Intoxicaciones**, etc.).
- **Hospitalización Obligatoria:** **Todo intento suicida debe ser hospitalizado**, idealmente en una unidad de psiquiatría o, en su defecto, en una cama de medicina con vigilancia.
- **Tratamiento de la Enfermedad de Base:** Una vez estabilizado, el objetivo es tratar la causa (ej. iniciar antidepresivos o fármacos antipsicóticos) para evitar la recurrencia.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Responsabilidad Médica: Dar de alta a un paciente con riesgo suicida inmediato puede acarrear graves consecuencias legales. La jurisprudencia chilena puede calificar el fallecimiento de un paciente dado de alta prematuramente como **cuasidelito de homicidio** por negligencia médica. No se debe dar el alta hasta que el riesgo haya sido evaluado y contenido por especialistas.

Evaluación de la Ideación Suicida

Cuando el paciente no ha cometido el intento, pero manifiesta deseos de morir (**ideación suicida**), el médico debe estratificar el riesgo para decidir la conducta.

Factores para evaluar el riesgo:

- **Plan Suicida:** ¿Tiene un plan estructurado (cuándo, cómo, dónde)? A mayor estructuración, mayor riesgo. - **Acceso a medios:** ¿Tiene disponibilidad de armas, cuerdas o medicamentos en su hogar? - **Intentos previos:** El antecedente de intentos anteriores es el predictor más fuerte de un suicidio consumado. - **Red de apoyo:** ¿Tiene familiares o amigos que puedan supervisarlo 24/7? - **Desesperanza:** El sentimiento de que "nada va a cambiar" es un signo de alarma grave.

Conducta según riesgo:

- **Riesgo Alto:** Hospitalización psiquiátrica inmediata (voluntaria o forzada si es necesario). - **Riesgo Bajo:** Se puede considerar el

manejo ambulatorio, siempre que se garantice: 1. Tratamiento inmediato de la patología de base. 2. Acompañamiento permanente de la familia. 3. Retiro de medios letales del hogar. 4. Control en el corto plazo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si decides un manejo ambulatorio en un paciente con ideación, es vital dejar un **registro detallado en la ficha clínica** justificando por qué el riesgo se considera bajo y cuáles son las medidas de seguridad adoptadas. Esto es tu principal defensa jurídica.

Resumen de Perlas EUNACOM

- **Depresión:** Causa más frecuente.
- **Hospitalización:** Regla de oro ante el intento.
- **Cluster B:** Grupo de personalidad con mayor asociación a intentos impulsivos.
- **Registro Clínico:** Fundamental para la protección legal del médico ante decisiones de manejo ambulatorio.
- **Manejo Inicial:** Siempre tratar primero la complicación médica (intoxicación/trauma) y luego la psiquiátrica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 25 años es traída a urgencias por su pareja después de ingerir 20 comprimidos de ibuprofeno como intento suicida. Está consciente, angustiada y refiere que lo hizo "en un momento de rabia". No tiene diagnóstico psiquiátrico previo. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos del Ánimo: Intento Suicida y Suicidio. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Todo intento suicida debe ser hospitalizado; dar el alta sin hospitalización puede ser negligencia médica.
- La causa más frecuente del intento suicida en Chile es la ingesta masiva de medicamentos.
- El suicidio consumado más frecuente es por ahorcamiento; en Santiago también es frecuente el lanzamiento al metro.
- La primera causa del suicidio es la depresión; también se asocia a trastorno bipolar, esquizofrenia y trastornos de personalidad clúster B.
- El trastorno de personalidad límite (borderline) tiene alta tasa de intentos suicidas por su impulsividad marcada.
- La ideación suicida con bajo riesgo puede manejarse ambulatoriamente, con registro detallado en la ficha que justifique la decisión.
- El trastorno histriónico frecuentemente tiene intentos suicidas como llamada de atención, pero con riesgo real de consumación si el intento falla.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DEL ÁNIMO: INTENTO SUICIDA Y SUICIDIO)**PREGUNTA 1**

Mujer de 25 años es traída a urgencias por su pareja después de ingerir 20 comprimidos de ibuprofeno como intento suicida. Está consciente, angustiada y refiere que lo hizo "en un momento de rabia". No tiene diagnóstico psiquiátrico previo. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Dar el alta con indicación de psicología ambulatoria después de estabilizar médicamente
- B)** Hospitalizar, manejar la intoxicación y evaluar enfermedad psiquiátrica de base
- C)** Solamente monitorizar laboratorios hepáticos por el ibuprofeno y dar el alta
- D)** Llamar a Carabineros para notificar el intento suicida
- E)** Evaluar el riesgo suicida: si es bajo, manejar ambulatoriamente

PREGUNTA 2

Hombre de 40 años con depresión mayor en tratamiento refiere en el control "a veces pienso que sería mejor morirme, pero no tengo ninguna intención de hacerme daño, no tengo plan y quiero seguir viviendo". No hay intentos previos. Su familia es un buen apoyo. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Hospitalizar de urgencia por ideación suicida
- B)** Ignorar la ideación y continuar con el tratamiento habitual
- C)** Evaluar el riesgo, documentar en ficha la evaluación y manejo ambulatorio con seguimiento estrecho
- D)** Derivar de urgencia a psiquiatría sin evaluarlo
- E)** Aumentar el antidepresivo a dosis máximas de inmediato

PREGUNTA 3

Mujer de 28 años con trastorno de personalidad límite es traída a urgencias por su madre. Tiene múltiples cortes superficiales en los antebrazos que se realizó "para no sentirse sola". Está angustiada pero sin intención de morir. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Dar el alta inmediata porque las lesiones son superficiales
- B)** Hospitalizar y evaluar riesgo suicida; tratar lesiones y contactar psiquiatría
- C)** Iniciar antidepresivos ISRS y dar el alta
- D)** Diagnóstico de simulación; no requiere manejo psiquiátrico
- E)** Tratar las lesiones físicas y citar a psicología en 2 semanas

RESUMEN: TRASTORNOS DEL ÁNIMO: INTENTO SUICIDA Y SUICIDIO

El intento suicida es una urgencia psiquiátrica frecuente en Chile. La forma más frecuente es la ingesta masiva de medicamentos. El suicidio consumado ocurre principalmente por ahorcamiento. Las causas más frecuentes del suicidio son: depresión (primera causa), trastorno bipolar, trastornos psicóticos (esquizofrenia descompensada) y trastornos de personalidad del clúster B (límite y antisocial principalmente). El trastorno de personalidad histriónico tiene alta frecuencia de intentos suicidas pero baja tasa de consumación. El narcisista raramente se suicida salvo en descompensación severa. Todo intento suicida debe hospitalizarse. Dar el alta a un paciente con intento suicida reciente sin la hospitalización adecuada puede constituir negligencia médica con eventual cuasi delito de homicidio. El tratamiento involucra el manejo médico de la intoxicación o lesión (según el método), tratamiento de la enfermedad de base y prevención de recurrencias. La ideación suicida sin intento requiere evaluación individualizada del riesgo. Los factores de alto riesgo incluyen: intentos previos, plan detallado, acceso a los medios, ideación clara y sostenida, y red de apoyo deficiente. Con riesgo bajo puede manejarse ambulatoriamente, con un registro detallado en la ficha clínica que justifique la decisión. Con riesgo alto la hospitalización es obligatoria. La diferencia entre ideación de muerte (pensar que morir sería una solución) e ideación suicida (pensar en quitarse la vida) es clínicamente relevante para la evaluación del riesgo.